

ASTHME DU NOURRISSON ET DE L'ENFANT: ÉVALUATION

Cycle de formation de résidanat

Dr Salma BEN AMEUR, Service de pédiatrie, CHU Hédi Chaker

21/10/2025

QCM1: Les éléments suivants caractérisent l'asthme

1. L'inflammation des voies aériennes
2. L'hyperréactivité bronchique
3. Le caractère allergique est constant
4. La variabilité des symptômes
5. L'obstruction bronchique fixé

QCM1: Les caractéristiques suivantes caractérisent l'asthme

1. L'inflammation des voies aériennes
2. L'hyperréactivité bronchique
3. Le caractère allergique est constant
4. La variabilité des symptômes
5. L'obstruction bronchique fixé

QCM 2: Le diagnostic d'asthme peut être évoqué chez un enfant de 20 mois devant :

- A. Un encombrement bronchique chronique
- B. Des épisodes de sifflements récurrents (≥ 3 épisodes)
- C. Une toux à l'effort (rire, pleurs)
- D. Une toux qui évolue depuis > 1 mois
- E. Des infections pulmonaires récurrentes

QCM 2: Le diagnostic d'asthme peut être évoquer chez un enfant de 20 mois devant :

- A. Un encombrement bronchique chronique
- B. Des épisodes de sifflements récurrents (≥ 3 épisodes)
- C. Une toux à l'effort (rire, pleurs)
- D. Une toux qui évolue depuis > 1 mois
- E. Des infections pulmonaires récurrentes

QCM3 :Les éléments anamnestiques en faveur du diagnostic de l'asthme chez l'enfant:

- A. La variation des symptômes respiratoires dans le temps
- B. Le déclenchement des symptômes respiratoires par les infections virales
- C. Une aggravation des symptômes respiratoires en milieu de journée
- D. Des symptômes respiratoires d'intensité non variable
- E. Association de plusieurs symptômes à type de dyspnée, toux, sifflements

QCM3 :Les éléments anamnestiques en faveur du diagnostic de l'asthme chez l'enfant:

- A. La variation des symptômes respiratoires dans le temps
- B. Le déclenchement des symptômes respiratoires par les infections virales
- C. Une aggravation des symptômes respiratoires en milieu de journée
- D. Des symptômes respiratoires d'intensité non variable
- E. Association de plusieurs symptômes à type de dyspnée, toux, sifflements

QCM4 :Les symptômes respiratoires évocateurs d'asthme chez un enfant de 6 ans :

- A. la toux
- B. La gêne à l'effort
- C. L'oppression thoracique
- D. Le Wheezing continu
- E. L'encombrement bronchique

QCM4 :Les symptômes respiratoires évocateurs d'asthme chez un enfant de 6 ans :

- A. la toux
- B. La gêne à l'effort
- C. L'oppression thoracique
- D. Le Wheezing continu
- E. L'encombrement bronchique

QCM 5 : L'examen physique en période inter-critique chez l'enfant asthmatique

- A. Est souvent normal
- B. La présence de râles sibilants à l'auscultation est fréquente
- C. Un hippocratisme digital est un signe d'inquiétude
- D. Un retentissement staturo-pondéral est fréquent
- E. Une peau sèche est un signe d'atopie

QCM5 : l'examen physique en période inter-critique chez l'enfant asthmatique

- A. Est souvent normal
- B. La présence de râles sibilants à l'auscultation est fréquente
- C. Un hippocratisme digital est un signe d'inquiétude
- D. Un retentissement staturo-pondéral est fréquent
- E. Une peau sèche est un signe d'atopie

QCM 6:Med âgé de 2 ans est amené en consultation par sa mère pour dyspnée sifflante à répétition, en faveur de l'asthme:

- A. Une cassure de la courbe pondérale
- B. Début des symptômes à la période néonatale
- C. Encombrement bronchique permanent
- D. Episodes récurrents et discontinues de sifflements (≥ 3)
- E. Toux sèche d'aggravation nocturne

QCM6 :Med âgé de 2 ans est amené en consultation par sa mère pour dyspnée sifflante à répétition, en faveur de l'asthme:

- A. Une cassure de la courbe pondérale
- B. Début des symptômes à la période néonatale
- C. Encombrement bronchique permanent
- D. Episodes récurrents et discontinues de sifflements(≥ 3)
- E. Toux sèche d'aggravation nocturne

QCM7 :Un seul élément anamnestique est contre le diagnostic d'asthme, chez une fille âgée de 3 ans qui présente des sifflements récurrents ?

- A. atopie familiale
- B. association à une toux à l'effort
- C. un début néonatal des symptômes
- D. Symptômes déclenchés par les infections virales des VAS
- E. association à une Toux nocturne

QCM7 :Un seul élément anamnestique est contre le diagnostic d'asthme, chez une fille âgée de 3 ans qui présente des sifflements récurrents ?

- A. Une atopie familiale
- B. association à une toux à l'effort
- C. **un début néonatal des symptômes**
- D. Des Symptômes déclenchés par les infections virales des VAS
- E. association à une Toux chronique nocturne

QCM 8:La radiographie thoracique au cours de l'asthme:

- A. Doit être demandée au moins une fois en intercritique
- B. Doit être demandée à chaque exacerbation
- C. Est souvent normale en inter-critique
- D. Doit être demandée au moins une fois/an en intercritique
- E. Permet de chercher des éléments en faveur d'un diagnostic différentiel

QCM 8 :La radiographie thoracique au cours de l'asthme:

- A. Doit être demandée au moins une fois en intercritique
- B. Doit être demandée à chaque exacerbation
- C. Est souvent normale en inter-critique
- D. Doit être demandée au moins une fois/an en intercritique
- E. Permet de chercher des éléments en faveur d'un diagnostic différentiel

QCM 9 :La radiographie thoracique au cours d'une crise d'asthme peut montrer :

- A. Une cardiomégalie
- B. Un pneumomédiastin
- C. Une asymétrie de la transparence
- D. Une distension thoracique
- E. Une horizontalization des cotes

QCM9 :La radiographie thoracique au cours d'une exacerbation d'asthme peut montrer:

- A. Une cardiomégalie
- B. Un pneumomédiastin
- C. Une asymétrie de la transparence
- D. Une distension thoracique
- E. Une horizontalization des cotes

QCM10 : Les éléments fonctionnelles respiratoires compatibles avec le diagnostic d'asthme

- A. Une distension pulmonaire avec un rapport VR/CPT supérieur à LIN
- B. Un trouble ventilatoire obstructif fixé
- C. Une augmentation des résistances des voies aériennes
- D. Une réversibilité post B2 avec une augmentation du VEMS $> 12\%$
- E. Une baisse du NO éxalé

QCM10 : Les éléments fonctionnelles respiratoires compatibles avec le diagnostic d'asthme

- A. Une distension pulmonaire avec un rapport VR/CPT supérieur à LIN
- B. Un trouble ventilatoire obstructif fixé
- C. Une augmentation des resistances des voies aériennes
- D. Une réversibilité post B2 avec augmentation du VEMS et/ou de la CVF > 12%
- E. Une baisse du NO exalé

QCM11 : Les éléments compatibles avec le diagnostic d'asthme chez l'enfant sur une courbe débit volume

- A. Un trouble ventilatoire obstructif fixé
- B. Un aspect concave en haut de la courbe pre B2 en cas de syndrome obstructif
- C. Un TVO proximal défini par $VEMS/CVF < \text{à LIN}$ ou un Z score $< -1,645$
- D. une réversibilité post B2 avec augmentation de 12% et 200ml du VEMS et/ou de la CVF
- E. une réversibilité post B2 avec augmentation de 12% du VEMS et/ou de la CVF

QCM11 : Les éléments compatibles avec le diagnostic d'asthme chez l'enfant sur une courbe débit volume

- A. Un trouble ventilatoire obstructif fixé
- B. Un aspect concave en haut de la courbe pre B2 en cas de syndrome obstructif
- C. Un TVO proximal défini par $VEMS/CVF < \text{à LIN}$ ou un Z score $< -1,645$
- D. une réversibilité post B2 avec augmentation de 12% et 200ml du VEMS et/ou de la CVF
- E. Une réversibilité post B2 avec augmentation de 12% du VEMS et/ou de la CVF

QCM 12: la spirométrie

- A. Fait partie des examens clés du diagnostic de l'asthme à l'âge scolaire
- B. est nécessaire pour le suivi de l'asthme à l'âge scolaire
- C. est réalisé tous les mois au cours du suivi de l'asthme à l'âge scolaire
- D. Peut être normale en période intercritique chez l'asthmatique
- E. En cas d'asthme, elle montre un syndrome restrictif

QCM 12: La spirométrie

- A. Fait partie des examens clés du diagnostic de l'asthme à l'âge scolaire
- B. Est nécessaire pour le suivi de l'asthme à l'âge scolaire
- C. Est réalisé tous les mois au cours du suivi de l'asthme à l'âge scolaire
- D. Peut être normale en période intercritique chez l'asthmatique
- E. En cas d'asthme, elle montre un syndrome restrictif

QCM13 :Jed, âgé de18 mois, est amené par ces parents à la consultation pour sifflements récurrents depuis l'age de 8 mois(4 épisodes) vous évoquez le diagnostic d'asthme. Quel(s) exploration(s) demandez vous?

- A. Aucun examen complémentaire car le diagnostic est clinique
- B. Radiographie thoracique de face
- C. Spirométrie avec courbes débit-volume
- D. Dosage pondéral des immunoglobulines
- E. IgE totales

QCM 13: Jed, âgé de 18 mois, est amené par ces parents à la consultation pour sifflements récurrents depuis l'âge de 8 mois (4 épisodes) vous évoquez le diagnostic d'asthme. Quel(s) exploration(s) demandez vous?

- A. Aucun examen complémentaire car le diagnostic est clinique
- B. Radiographie thoracique de face
- C. Spirométrie avec courbes débit-volume
- D. Dosage pondéral des immunoglobulines
- E. IgE totales

QCM14:les éléments cliniques en faveur de l'étiologie allergique de l'asthme chez l'enfant:

- A. La présence d'une dermatite atopique
- B. Un asthme chez la mère
- C. une symptomatologie essentiellement hivernale
- D. une allergie médicamenteuse chez un des parents
- E. l'association à une rhinite persistante

QCM14 :les éléments cliniques en faveur de l'étiologie allergique de l'asthme chez l'enfant:

- A. La présence d'une dermatite atopique
- B. Un asthme chez la mère
- C. une symptomatologie essentiellement hivernale
- D. une allergie médicamenteuse chez un des parents
- E. l'association à une rhinite persistante

QCM 15: les éléments cliniques en faveur de l'étiologie allergique de l'asthme chez l'enfant:

- A. Une rhino-conjonctivite allergique associée
- B. Un déclenchement des symptômes par l'effort
- C. Une dermatite atopique à l'examen clinique
- D. Présence d'animaux dans l'entourage
- E. des symptômes déclenchés par l'exposition à la poussière

QCM15 :les éléments cliniques en faveur de l'étiologie allergique de l'asthme chez l'enfant:

- A. Une rhino-conjonctivite allergique associée
- B. Un déclenchement des symptômes par l'effort
- C. Une dermatite atopique à l'examen clinique
- D. Présence d'animaux dans l'entourage
- E. des symptômes déclenchés par l'exposition à la poussière

QCM 16 : Les prick tests au cours de l'asthme:

- A. La lecture se fait après 48 heures
- B. Le témoin positif utilisé est l'histamine
- C. Sont réalisés après un arrêt des corticostéroïdes inhalés
- D. sont un examen fiable pour l'enquête allergologique
- E. Le témoin négatif utilisé est une solution de glycérine

QCM 16: Les prick tests au cours de l'asthme:

- A. La lecture se fait après 48 heures
- B. Le témoin positif utilisé est l'histamine
- C. Sont réalisés après un arrêt des corticostéroïdes inhalés
- D. sont un examen fiable pour l'enquête allergologique
- E. Le témoin négatif utilisé est une solution de glycérine

QCM 17:Concernant les prick tests:

- A. L'introduction de l'allergène se fait par voie intradermique
- B. Le témoin négatif est la codéine
- C. La réaction urticarienne est due à la dégranulation mastocytaire
- D. La lecture se fait 30 minutes après avoir déposer l'allergène
- E. Le test est positif si le diamètre de papule $\geq 3\text{mm}$ du témoin négatif et à 50% du témoin positif

QCM 17:Concernant les prick tests:

- A. L'introduction de l'allergène se fait par voie intradermique
- B. Le témoin négatif est la codéine
- C. La réaction urticarienne est due à la dégranulation mastocytaire
- D. La lecture se fait 30 minutes après avoir déposer l'allergène
- E. Le test est positif si le diamètre de papule $\geq 3\text{mm}$ du témoin négatif et à 50% du témoin positif

QCM 18: Les IgE spécifiques au cours de l'asthme:

- A. doivent être demandés chez tous les asthmatiques
- B. Peuvent être réalisés chez un patient sous antihistaminiques
- C. Sont utiles chez les patients ayant une dermatite atopique
- D. Sont peu coûteux
- E. Sont utiles en cas de dermographisme,

QCM 18 :Les IgE spécifiques au cours de l'asthme:

- A. doivent être demandés chez tous les asthmatiques
- B. Peuvent être réalisés chez un patient sous antihistaminiques
- C. Sont utiles chez les patients ayant une dermatite atopique
- D. Sont peu coûteux
- E. Sont utiles en cas de dermographisme,

QCM 19 : En faveur du caractère sévère d'une crise d'asthme chez un enfant de 4 ans :

- A. La prononciation de quelques mots
- B. Des râles sibilants expiratoires
- C. Une fréquence respiratoire $>40/\text{min}$
- D. Une fréquence cardiaque $>140/\text{min}$
- E. Une saturation en oxygène à 93% à l'air ambiant

QCM 19 : En faveur du caractère sévère d'une crise d'asthme chez un enfant de 4 ans :

- A. La prononciation de quelques mots
- B. Des râles sibilants expiratoires
- C. Une fréquence respiratoire $>40/\text{min}$
- D. Une fréquence cardiaque $>140/\text{min}$
- E. Une saturation en oxygène à 93% à l'air ambiant

QCM 20: Parmi les facteurs de risque d'un asthme aigu grave (FDR de Décès liés à l'asthme): :

- A. Allergie alimentaire confirmée associée à l'asthme
- B. Antécédents de crise sévère avec recours à la ventilation mécanique
- C. une rhinite allergique associée à l'asthme
- D. Absence de bronchodilatateur de longue durée d'action dans le traitement de fond de fond
- E. Utilisation fréquente de β_2 mimétiques

QCM 20: Parmi les facteurs de risque d'un asthme aigu grave (FDR de Décès liés à l'asthme): :

- A. Allergie alimentaire confirmée associée à l'asthme
- B. Antécédents de crise sévère avec recours à la ventilation mécanique
- C. une rhinite allergique associée à l'asthme
- D. Absence de bronchodilatateur de longue durée d'action dans le traitement de fond de fond
- E. Utilisation fréquente de $\beta 2$ mimétiques

Parmi les facteurs de risque d'un asthme aigu grave chez un enfant asthmatique , on retient :

- A) Consultations répétées aux urgences pour asthme, surtout au cours de la dernière année.
- B) Hospitalisation au cours de la dernière année
- C) Problèmes sociaux et familiaux
- D) Rhinite allergique associée
- E) Arrêt récent d'une corticothérapie orale

QCM21: Parmi les facteurs de risque d'un asthme aigu grave chez un enfant asthmatique , on retient :

- A) Consultations répétées aux urgences pour asthme, surtout au cours de la dernière année.
- B) Hospitalisation au cours de la dernière année
- C) Problèmes sociaux et familiaux
- D) Rhinite allergique associée
- E) Arrêt récent d'une corticothérapie orale

Les signes cliniques et paracliniques en faveur d'un asthme aigu grave chez un enfant de 6 ans

- hypotension
- Silence auscultatoire
- Une valeur de DEP 33%-55%
- Une fréquence respiratoire $>30/\text{min}$
- une normocaonie aux GDS

Les signes cliniques et paracliniques en faveur d'un asthme aigu grave chez un enfant de 6 ans

- hypotension
- Silence auscultatoire
- Une valeur de DEP 33%-55%
- Une fréquence respiratoire $>30/\text{min}$
- Une normocapnie aux GDS

QCM22 :Les signes faisant redouter le diagnostic d'asthme chez l'enfant :

- A. Déviation des bruits de cœur à droite
- B. Non amélioration sous traitement anti asthmatique
- C. Hippocratisme digital
- D. Taille à -1 déviation standard sur la courbe staturale
- E. Des sifflements recurents discontinus

QCM22 :Les signes faisant redouter le diagnostic d'asthme chez l'enfant :

- A. Déviation des bruits de cœur à droite
- B. Non amélioration sous traitement anti asthmatique
- C. Hippocratisme digital
- D. Taille à -1 déviation standard sur la courbe staturale
- E. Des sifflements recurents discontinus

QCM 23: Parmi les signes d'inquiétude qui font redouter le diagnostic d'asthme:

- A. Cassure de la courbe de croissance staturale
- B. Des infections des voies aériennes supérieures concomitantes
- C. Un début des symptômes dès la période néonatale
- D. Un wheezing discontinu
- E. Une diarrhée chronique

QCM23 : Parmi les signes d'inquiétude qui font redouter le diagnostic d'asthme:

- A. Cassure de la courbe de croissance staturale
- B. Des infections des voies aériennes supérieures concomitantes
- C. Un début des symptômes dès la période néonatale
- D. Un wheezing discontinu
- E. Une diarrhée chronique

QCM24 : Parmi les signes radiologiques d'inquiétude qui font redouter le diagnostic d'asthme chez un nourrisson de 18 mois

- A. une déviation trachéale à droite
- B. Une dextrocardie
- C. Un bouton aortique à droite
- D. Un syndrome bronchique
- E. Une atélectasie persistante

QCM24 : Parmi les signes radiologiques d'inquiétude qui font redouter le diagnostic d'asthme chez un nourrisson de 18 mois

- A. une déviation trachéale à droite
- B. Une dextrocardie
- C. Un bouton aortique à droite
- D. Un syndrome bronchique
- E. Une atélectasie persistante

QCM25 :En faveur de la mucoviscidose chez un enfant de 3 ans qui présente des sifflements récurrents

- A. Des infections ORL à répétition
- B. Un retard de croissance
- C. Un situs inversus
- D. Une diarrhée chronique
- E. ATCDS d'iléus méconial à la naissance

QCM25 : En faveur de la mucoviscidose chez un enfant de 3 ans qui présente des sifflements récurrents

- A. Des infections ORL à répétition
- B. Un retard de croissance
- C. Un situs inversus
- D. Une diarrhée chronique
- E. ATCDS d'iléus méconial à la naissance

QCM26 :les éléments cliniques en faveur du diagnostic d'une dyskinésie ciliaire chez un nourrisson de 10 mois qui présente des sifflements récurrents:

- A. Un début néontal des symptômes respiratoires
- B. Des otites chroniques
- C. Un situs inversus associé
- D. Une diarrhée chronique
- E. Un situs solitus

QCM26 :les éléments cliniques en faveur du diagnostic d'une dyskinésie ciliaire chez un nourrisson de 10 mois qui présente des sifflements récurrents:

- A. un début néonatal des symptômes respiratoires
- B. Des otites chroniques
- C. Un situs inversus associé
- D. Une diarrhée chronique
- E. Un situs solitus

QCM27 : parmi les diagnostics différentiels de l'asthme on retient

- ❑ la bronchite bactérienne persistante
- ❑ la trachéomalacie
- ❑ la dysplasie bronchopulmonaire
- ❑ le syndrome de widal
- ❑ la larynogomalacie

QCM27 : parmi les diagnostics différentiels de l'asthme on retient

- ❑ la bronchite bactérienne persistante
- ❑ la trachéomalacie
- ❑ la dysplasie bronchopulmonaire
- ❑ le syndrome de widal
- ❑ la larynogomalacie

QCM28 : Les comorbidités qui peuvent entraver le controle de l'asthme

- A. le RGO
- B. l'Obésité
- C. la rhinite allergique
- D. La conjonctivite allergique
- E. une maladie cœliaque équilibrée sous régime sans gluten

QCM28 : Les comorbidités qui peuvent entraver le contrôle de l'asthme

- A. le RGO
- B. l'Obésité
- C. la rhinite allergique
- D. La conjonctivite allergique
- E. une maladie cœliaque équilibrée sous régime sans gluten

QCM 29 : Concernant les bronchodilatateurs de courte durée d'action:

- A. La voie inhalée est la voie de référence
- B. Le bétanyl est prescrit à la dose de 0.01 ml/kg
- C. Ils peuvent provoquer des tremblements
- D. Ils peuvent provoquer une hyperkaliémie
- E. Ils peuvent provoquer une hypoglycémie

QCM29 :Concernant les bronchodilatateurs de courte durée d'action:

- A. La voie inhalée est la voie de référence
- B. Le bétanyl est prescrit à la dose de 0.01 ml/kg
- C. Ils peuvent provoquer des tremblements
- D. Ils peuvent provoquer une hyperkaliémie
- E. Ils peuvent provoquer une hypoglycémie

QCM 30 : Concernant le traitement de fond de l'asthme de l'enfant d'âge scolaire

- A. Il comporte 4 paliers
- B. Les corticoïdes inhalés (CSI) sont le traitement de référence
- C. Les BDLA sont un traitement additionnel à la CSI au palier 3
- D. Les antileucotriènes peuvent être prescrits en monothérapie au palier 2
- E. les BDLA peuvent être prescrits en monothérapie

QCM 30 : Concernant le traitement de fond de l'asthme de l'enfant d'âge scolaire

- A. Il comporte 4 paliers
- B. Les corticoïdes inhalés (CSI) sont le traitement de référence
- C. Les BDLA sont un traitement additionnel à la CSI au palier 3
- D. Les antileucotriènes peuvent être prescrits en monothérapie au palier 2
- E. les BDLA peuvent être prescrits en monothérapie

QCM31 :Les effets secondaires du salbutamol:

- A. Tremblements
- B. Hypoglycémie
- C. Hyperkaliémie
- D. Tachycardie
- E. Troubles du rythme cardiaque

QCM31 :Les effets secondaires du salbutamol:

- A. Tremblements
- B. Hypoglycémie
- C. Hyperkaliémie
- D. Tachycardie
- E. Troubles du rythme cardiaque

QCM 32: Concernant la corticothérapie systémique au cours d'une crise d'asthme:

- A. La voie orale est préférable
- B. L'administration précoce diminue le risque d'hospitalisation
- C. La voie parentérale est indiquée en cas de vomissements répétés
- D. Elle est indiquée pour une durée minimale de 10 jours
- E. La posologie est de 0,5 mg/kg/j pour le prednisolone

QCM 32:Concernant la corticothérapie systémique au cours d'une exacerbation d'asthme:

- A. La voie orale est préférable
- B. L'administration précoce diminue le risque d'hospitalisation
- C. La voie parentérale est indiquée en cas de vomissements répétés
- D. Elle est indiquée pour une durée minimale de 10 jours
- E. La posologie est de 0,5mg/kg/j pour le prednisolone

QCM 33 :Concernant le sulfate de magnésium

- A. il est indiqué dans les crises d'asthme sévères ne répondant pas au traitement initial
- B. il est administré par voie intramusculaire
- C. il est indiqué dans les crises d'asthme modérées
- D. il est administré par voie intraveineuse
- E. La posologie recommandée est de 40mg/kg

QCM 33 :Concernant le sulfate de magnésium

- A. il est indiqué dans les exacerbations sévères ne répondant pas au traitement initial
- B. il est administré par voie intramusculaire
- C. il est indiqué dans les crises d'asthme modérées
- D. il est administré par voie intraveineuse
- E. La posologie recommandée est de 40mg/kg

QCM 34 :L'Immunothérapie allergénique

- A. est le seul traitement étiologique de l'asthme allergique
- B. est indiqué en cas d'asthme sévère non contrôlé
- C. Peut être entamé à partir de l'âge de 5 ans
- D. Peut être entamé à partir de l'âge de 2 ans
- E. consiste à l'administration répétée d'allergènes afin d'induire une tolérance

QCM 34 :L'Immunothérapie allergénique

- A. est le seul traitement étiologique de l'asthme allergique
- B. est indiqué en cas d'asthme sévère non contrôlé
- C. Peut être entamé à partir de l'âge de 5 ans
- D. Peut être entamé à partir de l'âge de 2 ans
- E. consiste à l'administration répétée d'allergènes afin d'induire une tolérance

QCM 35 Le traitement de fond privilégié chez un enfant de 3 ans qui a présenté 3 crises d'asthme/an

- A. les CSI à faible dose quotidienne et BDCA à la demande
- B. les antileucotriènes et BDCA à la demande
- C. la CSI à faible dose + BDLA et BDCA à la demande
- D. Les BDCA à la demande
- E. les CSI à faible dose + antileucotriènes et BDCA à la demande

QCM 35 : Le traitement de fond privilégié chez un enfant de 3 ans qui a présenté 3 crises d'asthme/an

- A. les CSI à faible dose quotidienne et BDCA à la demande
- B. les antileucotriènes et BDCA à la demande
- C. la CSI à faible dose + BDLA et BDCA à la demande
- D. Les BDCA à la demande
- E. les CSI à faible dose + antileucotriènes et BDCA à la demande

QCM 36 : Parmi les moyens de prévention primaire de l'asthme, on retient

- A. proscrire le tabagisme passif
- B. réduire l'exposition aux moisissures(humidité)
- C. L'immunothérapie allergénique
- D. Encourager l'accouchement par voie basse
- E. Conseiller un traitement antihistaminique

QCM 36 : Parmi les moyens de prévention primaire de l'asthme, on retient

- A. proscrire le tabagisme passif
- B. réduire l'exposition aux moisissures(humidité)
- C. L'immunothérapie allergénique
- D. Encourager l'accouchement par voie basse
- E. Conseiller un traitement antihistaminique

QCM 37 :Amine âgé de 6 ans, asthmatique sous traitement de fond par CSI à doses faibles, présente des crises fréquentes au cours des 3 derniers mois, votre conduite initiale

1. changer le traitement de fond par association CSI+LABA
2. Evaluer l'observance thérapeutique
3. vérifier la technique d'inhalation
4. demander une TDM thoracique
5. Chercher une exposition au tabac

QCM 37 : Amine âgé de 6 ans, asthmatique sous traitement de fond par CSI à doses faibles, présente des crises fréquentes au cours des 3 derniers mois, votre conduite initiale

1. changer le traitement de fond par association CSI+LABA
2. Evaluer l'observance thérapeutique
3. vérifier la technique d'inhalation
4. demander une TDM thoracique
5. Chercher une exposition au tabac

QCM 37: concernant le traitement de fond à l'âge préscolaire

- ❑ les antileucotriènes peuvent être prescrits à partir de l'âge de 3 mois
- ❑ la corticothérapie inhalée est la base du traitement de fond
- ❑ des sifflements épisodiques (<3ans) indiquent une CSI quotidienne à dose moyennes
- ❑ une immunothérapie allergénique est indiquée si l'asthme est contrôlé
- ❑ le pallier 2 comprend une CSI quotidienne à dose faible

QCM 37: Concernant le traitement de fond à l'âge préscolaire

- les antileucotriènes peuvent être prescrits à partir de l'âge de 3 mois
- la corticothérapie inhalée est la base du traitement de fond
- des sifflements épisodiques (<3ans) indiquent une CSI quotidienne à dose moyennes
- une immunothérapie allergénique est indiquée si l'asthme est contrôlé
- le palier 2 comprend une CSI quotidienne à dose faible

Cas clinique 1

Amal, âgée de 7 ans, asthmatique connue sous traitement de fond, présente depuis 48 heures une toux sèche et une gêne respiratoire non améliorée après la prise de BDCA, ce jour aggravation des symptômes avec consultation aux urgences

A l'examen:

- Eutrophique, $T^{\circ}=37^{\circ}\text{C}$
- FC= 100/min
- TA= 110/65 mmHg
- FR= 30/min, SaO₂= 92% à l'air ambiant
- Tirage sous et inter costal modéré
- AP: râles sibilants aux 2 temps, pas de difficulté de parler
- Le reste de l'examen: normal

Cas clinique1 QCM n°1:

La prise en charge thérapeutique pendant la première heure inclut :

- A. 3 nébulisations de BDCA à 20 minutes d'intervalle sous oxygène
- B. 1 nébulisations de BDCA et réévaluer à H1
- C. Corticothérapie par prednisolone 1 mg/Kg
- D. Nébulisation de Corticothérapie inhalé
- E. Sulfate de magnésuin en IVL

Cas clinique1 QCM n°1:

la prise en charge thérapeutique pendant la première heure inclut :

- A. 3 nébulisations de BDCA à 20 minutes d'intervalle sous oxygène
- B. 1 nébulisations de BDCA et réévaluer à H1
- C. Corticothérapie par prednisolone 1 mg/Kg/j
- D. Nébulisation de Corticothérapie inhalé
- E. Sulfate de magnésuin en IVL

Cas clinique1 QCM n°2:

Quel(s) examen(s) complémentaire(s) demandez vous?

- A. Aucun
- B. Radiographie du thorax
- C. Gaz du sang
- D. Ionogramme sanguin
- E. NFS et CRP

Cas clinique1 QCM n°2:

Quel(s) examen(s) complémentaire(s) demandez vous?

- A. **Aucun**
- B. Radiographie du thorax
- C. Gaz du sang
- D. Ionogramme sanguin
- E. NFS et CRP

Cas clinique1 QCM n°3:

L'évaluation à H1 montre une saturation en oxygène à 97%, absence de signes de lutte respiratoire et une FR à 25 c/min, vous proposez:

- A. Aérol® 2 bouffées X 4/ j pendant 7 j avec chambre d'inhalation
- B. Aérol® 1 bouffée/2 Kg/20 minutes en 1 heure puis réévaluer à H4
- C. Corticothérapie orale (prednisolone 1mg/kg) pendant 3 à 5 jours
- D. Hospitalisation et nébulisation de BDCA toutes les 4 heures
- E. Plan d'action écrit

Cas clinique1 QCM n°3:

L'évaluation à H1 montre une saturation en oxygène à 97%, absence de signes de lutte respiratoire et une FR à 25 c/min, vous proposez:

- A. **Aérol® 2 bouffées X 4/ j pendant 7 j avec chambre d'inhalation**
- B. **Aérol® 1 bouffée/2 Kg/20 minutes en 1 heure puis réévaluer à H4**
- C. **Corticothérapie orale (prednisolone 1mg/kg) pendant 3 jours**
- D. **Hospitalisation et nébulisation de BDCA toutes les 4 heures**
- E. **Plan d'action écrit**

Cas clinique2 QCM n°1:

Salim, âgé de 3 ans, est hospitalisé pour dyspnée aigue. A l'examen:

- Apyrétique, poids=14 kg
- FC= 160/min; TA correcte
- FR= 45 c/min, SaO₂= 88% à l'air ambiant
- Signes de luttés marqués
- AP: râles sibilants
- Reste de l'examen: normal

Cas clinique2 QCM n°2:

Quels sont le(s) diagnostic(s) possible(s)?

- A. Pneumopathie aigue communautaire
- B. crise d'asthme sévère
- C. Inhalation de corps étranger
- D. Epiglottite
- E. Staphylococcie pleuropulmonaire

Cas clinique 2 QCM n°2:

Quels sont le(s) diagnostic(s) possible(s)?

- A. Pneumopathie aigue communautaire
- B. **crise d'asthme sévère**
- C. **Inhalation de corps étranger**
- D. Epiglottite
- E. Staphylococcie pleuropulmonaire

Cas clinique2 QCM n°3:

Quelle est la conduite à tenir immédiate?

- A. Antibiothérapie par ceftriaxone
- B. Nébulisations de bricanyl® + Atrovent®
- C. Oxygénothérapie pour maintenir la $SpO_2 > 94\%$
- D. Corticothérapie systémique
- E. Ventilation mécanique

Cas clinique2 QCM n°3:

Quelle est la conduite à tenir immédiate?

- A. Antibiothérapie par ceftriaxone
- B. Nébulisation de bricanyl® + Atrovent®
- C. Oxygénothérapie pour maintenir la $SaO_2 > 94\%$
- D. Corticothérapie systémique
- E. Ventilation mécanique

Cas clinique 2QCM n°4:

A l'interrogatoire, pas de syndrome de pénétration, il a présenté 3 épisodes traités en ambulatoire. L'évaluation à H1 de la prise en charge : mauvaise réponse au traitement, Quel serez votre CAT ?

- A. Antibiothérapie par ceftriaxone
- B. Sulfate de magnésium par voie intraveineuse
- C. Radiographie du thorax
- D. continuer les nébulisations de BDCA toutes les 20 minutes
- E. Bronchoscopie en urgence

Cas clinique 2QCM n°4:

A l'interrogatoire, pas de syndrome de pénétration, il a présenté 3 épisodes traités en ambulatoire. L'évaluation à H1 de la prise en charge : mauvaise réponse au traitement, Quel serez votre CAT ?

- A. Antibiothérapie par ceftriaxone
- B. Sulfate de magnésium par voie intraveineuse
- C. Radiographie du thorax
- D. continuer les nébulisations de BDCA sous O2 toutes les 20 minutes
- E. Bronchoscopie en urgence

Cas clinique2 QCM n°5:

Evolution : amélioration des symptômes sous traitement et à J3 d'hospitalisation vous indiquez la sortie

Quel traitement de fond indiquez vous chez cet enfant de premi?

- A. BDCA à la demande
- B. Anti leucotriènes +BDCA à la demande
- C. CSI à doses faibles à moyennes quotidienne et BDCA à la demande
- D. CSI intermittente et BDCA à la demande
- E. CSI faible dose + BDLA quotidienne et BDCA à la demande

Cas clinique2 QCM n°5:

Evolution : amélioration des symptômes sous traitement et à J3 d'hospitalisation vous indiquez la sortie

Quel traitement de fond indiquez vous chez cet enfant de premi?

- A. BDCA à la demande
- B. Anti leucotriènes +BDCA à la demande
- C. CSI à doses faibles à moyennes quotidienne et BDCA à la demande
- D. CSI intermittente et BDCA à la demande
- E. CSI faible dose + BDLA quotidienne et BDCA à la demande

Cas clinique2 QCM n°4:

Quel(s) dispositif(s) d'inhalation peut on choisir chez ce patient?

- A. Aerosol doseur avec chambre d'inhalation+ masque
- B. Aerosol doseur avec chambre d'inhalation+ embout buccal
- C. Aérosol doseur
- D. Inhalateur de poudre sèche (diskus)
- E. Nébuliseur avec masque

Cas clinique2 QCM n°4:

Quel(s) dispositif(s) d'inhalation peut on choisir chez ce patient?

- A. **Aérosol doseur avec chambre d'inhalation+ masque**
- B. Aérosol doseur avec chambre d'inhalation+ embout buccal
- C. Aérosol doseur
- D. Inhalateur de poudre sèche (diskus)
- E. **Nébuliseur avec masque**

Cas clinique 3 :

Emna, âgée de 9 ans, est adressée à la consultation pour suspicion d'asthme.

ATCDS personnels : RAS

Mère asthmatique

3 épisodes de sifflements en 6 mois (recours aux urgences pour nébulisations de BDCA+ corticothérapie orale)

Toux sèche diurne et nocturne quotidienne avec gêne à l'effort

tabagisme passif+, pas d'humidité

Eutrophique, peau sèche , obstruction nasale, ACP normale

Cas clinique 3 QCM1: les examens complémentaires à demander chez cet enfant

- ☐ les pricks tests
- ☐ la radiothorax
- ☐ la spirométrie avec un test de bronchodilatation
- ☐ la NFS
- ☐ Le dosage des IGE totales

Cas clinique 3 QCM1: les examens complémentaires à demander chez cet enfant

- ☐ les pricks tests
- ☐ la radiothorax
- ☐ la spirométrie avec un test de bronchodilatation
- ☐ la NFS
- ☐ Le dosage des IGE totales

Cas clinique 3 QCM n°2:

Quels sont les éléments cliniques de mauvais contrôle de l'asthme chez Emna?

- A. Toux nocturne quotidienne
- B. Limitation de l'activité physique
- C. Symptômes diurnes quotidiens
- D. Présence d'une dermatite atopique associée
- E. Tests cutanés positifs aux acariens

Cas clinique3 QCM n°2:

Quels sont les éléments de mauvais contrôle de l'asthme chez Emna?

- A. Toux nocturne quotidienne
- B. Limitation de l'activité physique
- C. Symptômes diurnes quotidiens
- D. Présence d'une dermatite atopique associée
- E. Tests cutanés positifs aux acariens

Cas clinique3 QCM n°3: les examens demandés montrent : Radio thorax: normale
Tests cutanés: positifs aux acariens , $EFR = VEMS/CVF < LIN(Z \text{ score} - 2)$, Gain de 13% sur le VEMS après bronchodilatateurs

La prise en charge thérapeutique inclut ?

- A. Immunothérapie allergénique aux acariens
- B. CSI à dose faible à moyenne+ BDLA et BDCA à la demande
- C. CSI dose faible à chaque administration de BDCA
- D. Mesures anti-acariens
- E. Proscrire le tabagisme passif

Cas clinique3 QCM n°3: les examens demandés montrent : Radio thorax: normale
Tests cutanés: positifs aux acariens , $EFR = VEMS/CVF < LIN(Z \text{ score} - 2)$, Gain de 13% sur le VEMS après bronchodilatateurs

La prise en charge thérapeutique inclut ?

- A. Immunothérapie allergénique aux acariens
- B. CSI à dose faible à moyenne+ BDLA et BDCA à la demande
- C. CSI dose faible à chaque administration de BDCA
- D. Mesures anti-acariens
- E. Proscrire le tabagisme passif